

# IV

поколение фторхинолонов  
в борьбе с инфекцией

# ВЕЛЛОЦИН®

Моксифлоксацин 100 мл- 400 мг

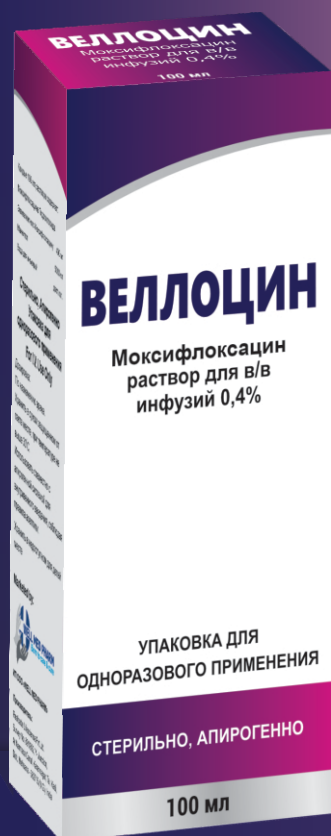
## Преимущество:

Антибиотик широкого спектра действия, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов

Эффективная альтернатива лечению внебольничной пневмонии, вызванной как типичными, так и атипичными бактериальными возбудителями.

Моксифлоксацин был эффективнее офлаксацина в отношении энтеробактерий

Моксифлоксацин более эффективен, чем ципрофлоксацин и офлаксацин, в отношении грамположительных патогенов, может быть сравним по активности в отношении менее чувствительных к хинолонам



## Показания к применению



**Острый  
бактериальный  
синусит**



**Хронический  
бронхит**



**Инфекция  
мочевыводящих  
путей (ИМП)**



**Инфекции  
кожи и мягких  
тканей**



**Внебольничная  
пневмония**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВЕЛЛОЦИН

**Торговое название препарата:** Веллоцин

**Действующее вещество (МНН):** моксифлоксацина гидрохлорид

**Лекарственная форма:** раствор для инфузий 400мг/100 мл

**Состав:** 100 мл раствора содержит:

**активное вещество:** моксифлоксацина 400 мг

**вспомогательные вещества:** маннитол, натрия ацетата тригидрат, хлористоводородная кислота, вода для инъекций.

**Описание:** прозрачная жидкость желтоватого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** антибактериальное синтетическое средство (гр.фторхинолонов).

**Код АТХ:** J01MA14

**Фармакологические свойства**

Моксифлоксацин относится к группе антибактериальных средств фторхинолонового класса.

Моксифлоксацин активен *in vitro* в отношении большинства штаммов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Ингибирует топоизомеразу II (ДНК-гираза) и топоизомеразу IV — ферменты, необходимые для репликации, транскрипции, репарации и рекомбинации бактериальной ДНК. Нарушает синтез ДНК микробной клетки, оказывает бактерицидное действие. Механизм действия фторхинолонов, включая моксифлоксацин, отличается от действия макролидов, бета-лактамов, аминогликозидов и тетрациклинов, следовательно микроорганизмы, резистентные к этим классам препаратов, могут быть чувствительны к моксифлоксацину.

Перекрестная резистентность между моксифлоксацином и другими классами противомикробных средств (включая макролиды, бета-лактамы, антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины) не известна.

Моксифлоксацин активен в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов:

- *аэробные грамположительные микроорганизмы* — *Staphylococcus aureus* (только метициллиночувствительные штаммы), *Streptococcus pneumoniae* (включая мультирезистентные штаммы), *Enterococcus faecalis* (только штаммы, чувствительные к ванкомицину и гентамицину), *Streptococcus pyogenes*;

- *аэробные грамотрицательные микроорганизмы* — *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*;

- *другие микроорганизмы* — *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.

По данным *in vitro* исследований, моксифлоксацин активен, но клиническая значимость этих полученных *in vitro* данных не определена.

Моксифлоксацин проявляет *in vitro* минимальную ингибиторную концентрацию (МПК  $\leq 2$  мкг/мл) в отношении большинства (более 90%) штаммов следующих микроорганизмов:

- *аэробные грамположительные микроорганизмы* — *Staphylococcus epidermidis* (только метициллиночувствительные штаммы), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus viridans*;

- *аэробные грамотрицательные микроорганизмы* — *Citrobacter freundii*, *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella oxytoca*, *Escherichia coli*, *Legionella pneumophila*, *Proteus mirabilis*;

- *анаэробные микроорганизмы* — *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.*.

**Фармакокинетика**

**Распределение**

Связывание с белками сыворотки составляет около 50% и не зависит от концентрации вещества. Хорошо распределяется по тканям и жидкостям организма: слизистой бронхов, спинномозговой жидкости, максиллярно-синусной слизистой, слюне, коже.

**Метаболизм**

Препарат метаболизируется в печени. Он метаболизируется до неактивных метаболитов, таких как сульфаты или глюкорониды.

**Выведение**

15-21% неизмененного препарата выводится с мочой и около 25% с калом.

Период полураспада препарата составляет 9-16 часов.

**Способ применения и дозы**

| Инфекции                                      | Суточная доза | Длительность применения |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Острые бактериальные синуситы                 | 400 мг        | 10 дней                 |
| Острые бактериальные бронхиты и их обострение | 400 мг        | 5 дней                  |
| Пневмония                                     | 400 мг        | 7-14 дней               |
| Неосложненные инфекции кожи и ее структур     | 400 мг        | 7 дней                  |

**Противопоказания**

- известная гиперчувствительность к моксифлоксацину, другим фторхинолонам или любым другим ингредиентам данного препарата.

- пациенты, у которых в анамнезе были случаи разрыва сухожилий, связанные с приемом фторхинолонов.

- документированное пролонгирование QT.

**Форма выпуска**

По 100 мл препарата в полиэтиленовом флаконе.

**Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 30°C. Не замораживать.

**Срок годности**

2 года.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.